Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9° andar, sala 907 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5241533-02.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: CRISTINE DOS SANTOS DE LEMOS

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A.

SENTENÇA

CRISTINE DOS SANTOS DE LEMOS ajuizou Ação Ordinária com pedido liminar de tutela de urgência em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., buscando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) para o tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (CID 10 G35), doença que a acomete. A Autora narrou ser beneficiária do plano AMIL SAÚDE categoria AMIL S750, com cobertura ambulatorial e hospitalar de abrangência nacional. Afirmou que, aos 45 anos, foi diagnosticada em julho de 2023 com Esclerose Múltipla na forma Primariamente Progressiva, com um quadro clínico grave e progressivo, caracterizado por ataxia de marcha, perda de força e dores nas pernas, fraqueza nos braços e perda do controle esfincteriano, além de múltiplas lesões desmielinizantes no cérebro e na medula cervical e torácica, conforme laudo médico acostado aos autos. Ressaltou que a patologia se encontra em fase precoce (EDSS 4.5), mas com caráter ativo de evolução, implicando acúmulo de sequelas motoras, cognitivas, sensitivas e urinárias. Sustentou que o medicamento Ocrelizumabe é a única medicação comprovadamente eficaz para a Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, conforme indicação em bula, aprovada pela ANVISA desde 26/02/2018, e com ampla evidência científica, além de recomendações de agências estrangeiras renomadas como a FDA nos EUA e a NICE no Reino Unido. Apontou que a ré, recusou o fornecimento do fármaco administrativamente, alegando ausência de comprovação de eficácia e/ou efetividade e não preenchimento das Diretrizes de Utilizaçãoda ANS. Argumentou a urgência do tratamento para evitar a progressão da doença, que já vinha causando declínio em sua capacidade de marcha e memória, culminando em risco de acúmulo de incapacidade irreversível e piora da qualidade de vida. Requereu, em caráter de urgência, o imediato fornecimento do medicamento e, ao final, a procedência total dos pedidos, com a confirmação da tutela provisória.

O pedido de gratuidade judiciária formulado pela Autora foi indeferido (evento 3, DESPADEC1). Foi requerida nota técnica ao NATJus, que foi acostada no evento 7, ANEXO1.

Foi deferida a tutela de urgência (evento 19, DESPADEC1). Naquela ocasião, este Juízo determinou que a Ré fornecesse o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), na dose de 300mg, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a 30 dias.

A Ré comprovou o cumprimento da liminar concedida (evento 38, PET1), autorizando o fornecimento da medicação à Autora.

Em contestação (evento 39, CONT1), a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. impugnou o valor da causa e o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou ausência de obrigatoriedade de cobertura para o medicamento Ocrelizumabe nos termos da DUT 65.13 da ANS, afirmando que a negativa se baseou na não inclusão da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva nas hipóteses de cobertura obrigatória, embora o medicamento constasse no rol para outras indicações. Argumentou que a Lei nº 14.454/2022 não afasta a taxatividade do rol da ANS de forma irrestrita, e que a responsabilidade pelo custeio de medicamentos não cobertos pela saúde suplementar recairia sobre o SUS. Por fim, impugnou a inversão do ônus da prova e requereu a improcedência dos pedidos da Autora, solicitando a produção de prova pericial médica.

A Autora apresentou réplica (evento 46, RÉPLICA1).

As preliminares de impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita foram rejeitadas na decisão doevento 48, DESPADEC1. Na mesma decisão, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a produção de provas. A Autora informou não ter interesse em produzir novas provas, requerendo o julgamento antecipado do mérito (evento 53, PET1). A Ré, por sua vez, reiterou o pedido de produção de prova pericial (evento 54, PET1), o que foi deferido (evento 56, DESPADEC1).

O laudo pericial foi juntado aos autos no evento 153, LAUDO1. O Perito confirmou o diagnóstico da Autora de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (CID 10 G35) e atestou que o Ocrelizumabe é a única medicação com evidência comprovada para essa condição, com prescrição de acordo com a bula aprovada pela ANVISA.

Após a juntada do laudo pericial, a Ré se manifestou (evento 159, PET1), reiterando a improcedência dos pedidos da Autora com base na exclusão da EMPP da cobertura obrigatória pela DUT 65.13 da ANS, confirmada pelo Perito. A Autora, em sua manifestação (evento 161, PET1), reforçou que o laudo pericial corrobora a eficácia e a necessidade do medicamento, e que a Lei nº 14.454/2022 ampara a cobertura excepcional, mesmo diante da exclusão da DUT.

Em 27/06/2025 (evento 165, DESPADEC1), a prova pericial foi declarada finalizada, com a determinação de liberação do saldo dos honorários periciais e a conclusão dos autos para julgamento.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas, conforme dita o artigo 355, I, do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora, portadora de Esclerose Múltipla na forma Primariamente Progressiva (EMPP), pretende o fornecimento de medicamento/custeio de tratamento de Ocrelizumabe (Ocrevus), em vista da negativa de fornecimento pela ré.

De início, observo que a relação entretida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, o que já se encontra sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)."

Tratando-se de demanda envolvendo o dever do plano de saúde em custear tratamento médico, é fundamental lembrar que está em jogo um direito fundamental, o direito à saúde, classificado como direito de segunda geração e expressamente assegurado pela Constituição Federal, conforme disposto nos artigos 6º e 196, cujos termos destacam a relevância desse direito como garantia essencial.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No tocante ao direito à saúde suplementar, a legislação pátria compreende determinados normativos, isto é, a Lei nº 9.656/1998 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, os quais conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde.

A ré negou-se a custear o medicamento Ocrelizumabe, com base na exclusão da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP) das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Contudo, em que pese o Perito judicial tenha confirmado que *"a DUT 65.13 exclui a Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva da cobertura obrigatória para ocrelizumabe"* (evento 153, LAUDO1, resposta ao quesito 17), tal fato, por si só, não justifica a recusa da operadora.

A Lei nº 9.656/1998, em seu artigo 10, § 13, introduzido pela Lei nº 14.454/2022, estabelece critérios para a cobertura de tratamentos ou procedimentos prescritos por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol da ANS. Confira-se:

> *Art. 10. (...)*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento* ***prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em* ***evidências científicas*** *e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,* ***no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais***

No presente caso, o conjunto probatório demonstra de forma robusta o preenchimento de tais requisitos. O laudo médico assistente (Evento 1, LAUDO9) e, principalmente, o laudo pericial (evento 153, LAUDO1), confirmam o diagnóstico da Autora e a imprescindibilidade do Ocrelizumabe. O Perito judicial foi enfático ao concluir que:

> Conclui-se que o uso do ocrelizumabe é clinicamente indicado, sendo atualmente a única medicação para esclerose múltipla primariamente progressiva com eficácia comprovada por ensaio clínico randomizado.

Ademais, o médico assistente e o Perito mencionam a aprovação do medicamento pela ANVISA (evento 1, OUT20), com indicação em bula para EMPP, colaciono:

> **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**
> **Ocrevus®** é indicado para o tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP).

Saliento que foi referenciado sobre estudos científicos como o ensaio clínico ORATORIO (evento 1, OUT19), além de agências internacionais como a FDA e a NICE. A Nota Técnica do NATJus (evento 7, ANEXO1) também se manifestou favoravelmente à concessão, salientando que "o Ocrelizumabe é o único medicamento aprovado para tratamento da forma primariamente progressiva da doença", conforme colaciono:

Conclusão: Trata-se de solicitação do medicamento Ocrelizumabe para tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva.
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares.
A Esclerose múltipla primariamente progressiva (EMPP) representa aproximadamente 10% dos casos de Esclerose múltipla (EM) e é caracterizada pela progressão da doença desde o início, embora possam ocorrer platôs ocasionais, pequenas melhorias temporárias e, menos provavelmente, recaídas agudas. A EMPP geralmente se apresenta com progressão neurológica insidiosa, mais frequentemente como uma mielopatia que piora gradualmente com dificuldade de marcha.
Para pacientes com EMPP mais jovens (por exemplo, idade ≤55 anos) ou com doença ativa na ressonância magnética, há reco,endação de tratamento com Ocrelizumabe (grau 2B). O tratamento com Ocrelizumabe pode ser ofertado a pacientes com EMPP mais velhos e com doença inativa, mas pacientes com essas características podem ter menor probabilidade de se beneficiar e maior probabilidade de sofrer efeitos adversos. Além do Ocrelizumabe, os ensaios de outras terapias modificadoras da doença usadas em pacientes com Esclerose múltipla recorrente-remitente (EMRR) não conseguiram demonstrar evidências de benefício em pacientes com EMPP.
Outros tratamentos que foram testados para EMPP (por exemplo, pulsos de glicocorticóides, Methotrexate, Imunoglobulina intravenosa, Mitoxantrona) carecem de evidências convincentes de eficácia em ensaios clínicos; a maioria dos especialistas em EM não usa esses medicamentos para EMPP rotineiramente.
Considerando que o Ocrelizumabe é o único medicamento aprovado para tratamento da forma primariamente progressiva da doença, este parecer é favorável à sua concessão.

Dessa forma, fica comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas e o plano terapêutico, conforme o inciso I do § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998. Além disso, a recomendação por agências internacionais de renome, bem como a aprovação da ANVISA com indicação em bula para a condição da Autora, satisfazem o inciso II da referida norma. É crucial observar que a exclusão de uma condição específica de uma DUT da ANS não significa que o tratamento seja "off label" ou experimental, mas apenas que não está contemplado na lista de cobertura obrigatória por aquela diretriz.

Contudo, a Lei nº 14.454/2022 visa justamente abarcar situações em que, apesar de não haver previsão na DUT, a evidência científica e a recomendação médica fundamentam a necessidade do tratamento.

A alegação da Ré de que o medicamento seria de uso domiciliar e, portanto, de responsabilidade do SUS, não procede. A Autora e o médico assistente esclareceram que o Ocrelizumabe é uma terapia imunobiológica de uso restrito hospitalar, o que afasta a tese da operadora de saúde.

O direito à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente, impõem que a interpretação das normas regulatórias dos planos de saúde seja teleológica, buscando sempre a máxima efetividade desses direitos fundamentais. A operadora de saúde não pode se imiscuir na escolha terapêutica do médico assistente, especialmente quando esta é fundamentada e se mostra como a única alternativa comprovadamente eficaz para uma doença grave e progressiva. Limitar o tratamento a meros procedimentos previstos taxativamente, desconsiderando o avanço da ciência e a necessidade individual do paciente, desvirtua a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

O valor da causa foi mantido em R$ 174.221,76, correspondente a doze meses de tratamento, em conformidade com o artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, e o pedido de justiça gratuita restou sem objeto, tendo em vista o recolhimento das custas processuais.

Nesse cenário, a recusa de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde se mostra ilícita, porquanto há expressa indicação médica para o tratamento em questão pelo médico que acompanha a autora, evidências científicas sobre o medicamento proposto, bem como recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** o pedido formulado por CRISTINE DOS SANTOS DE LEMOS em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e, em consequência, confirmo a tutela de urgência deferida no Evento 19 para condenar a Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. a fornecer à Autora CRISTINE DOS SANTOS DE LEMOS o medicamento **OCRELIZUMABE (Ocrevus) 300mg**, na dosagem e periodicidade indicadas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da procuradora da Autora, os quais fixo em R$ 3.500,00, nos termos do artigo 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil, eis que excessivos se arbitrados sobre o valor da causa, considerando a natureza da matéria, o trabalho exigido dos profissionais e o tempo de tramitação da demanda.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 05/10/2025, às 18:39:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091990197v7** e o código CRC **5a1204fb**.